第109回看護師国家試験（2020年実施）　眼科に関連する問題と解説

収録17問（直接眼科5・関連領域6・弱い関連6）。実施日：令和2年2月16日。作成日：2026-10-19。

各問を「問題文・全選択肢（原文）」「選択肢別の判定・解説」「公式正答」の順に掲載します。正答は厚生労働省の正答表に基づきます。解説は独自に作成した学習用原稿で、公式解説ではありません。「誤っているもの」を選ぶ問題では、誤った記述が正答です。

出典：厚生労働省ホームページ「第109回看護師国家試験の問題および正答について」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html（2026-10-19利用）。読み仮名・改行・字間を整理し、英語病名の併記を省略したうえで学習用解説を追加した編集物です。図・写真は転載していません。Webサイト：https://adash333.github.io/nurse-ganka/r/

問題一覧

問題ID	区分	分類	テーマ	公式正答
109A09	必修	関連領域	死の三徴候（角膜混濁）	3
109A25	必修	弱い関連	有訴者の症状（目のかすみ）	1
109A40	一般	関連領域	壮年期の身体的特徴（明暗順応）	2
109A46	一般	関連領域	細菌性髄膜炎の症状（羞明）	1
109A76	一般	直接眼科	眼球に入る光の量の調節	2
109A79	一般	弱い関連	重症筋無力症	4
109A81	一般	関連領域	交感神経の作用（散瞳）	1・2
109A94	状況設定	関連領域	糖尿病患者のアセスメント（視力低下・緑内障）	3
109B08	必修	関連領域	老年期の身体的変化（水晶体）	1
109B12	必修	弱い関連	三叉神経の機能（視覚・眼球運動の選択肢）	3
109B51	一般	直接眼科	網膜剝離・硝子体手術後の体位	2
109B52	一般	直接眼科	散瞳薬を用いる眼底検査の看護	3
109B75	一般	直接眼科	視覚障害者への避難所での対応	3
109B83	一般	直接眼科	加齢黄斑変性の症状	5
109B92	状況設定	弱い関連	甲状腺全摘後の症状（目が閉じにくい）	1
109B94	状況設定	弱い関連	閉塞性黄疸（眼球結膜の黄染）	3
109B115	状況設定	弱い関連	糖尿病網膜症による視力障害とインスリン自己注射	3

109A09　死の三徴候（角膜混濁）

区分：必修／分類：関連領域／主題：瞳孔所見と死の三徴候／出典：午前問題PDF 9ページ

死の三徴候に含まれるのはどれか。

1　筋の弛緩
2　角膜の混濁
3　呼吸の停止
4　呼名反応の消失

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	筋の弛緩は三徴候ではない（死後硬直の前段階）。
2	誤答	角膜混濁は死後の変化で、死の判定の三徴候ではない。
3	正答	呼吸停止は三徴候の一つ。
4	誤答	呼名反応の消失は意識障害でも起こる。

公式正答：3　呼吸の停止

ポイント：瞳孔散大と対光反射の消失は脳幹機能停止の指標として三徴候に含まれる。

109A25　有訴者の症状（目のかすみ）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：統計にみる眼症状／出典：午前問題PDF 14ページ

平成28年（2016年）の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。

1　腰痛
2　もの忘れ
3　体がだるい
4　目のかすみ
5　手足の関節が痛む

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	男性は腰痛が最多。
2	誤答	もの忘れは上位ではない。
3	誤答	体がだるいは上位の一つ。
4	誤答	目のかすみは上位の訴えだが最多ではない。
5	誤答	手足の関節が痛むは上位の一つ。

公式正答：1　腰痛

109A40　壮年期の身体的特徴（明暗順応）

区分：一般／分類：関連領域／主題：水晶体・加齢（老視）／出典：午前問題PDF 19ページ

壮年期の身体的特徴で正しいのはどれか。

1　運動耐久力の向上
2　明暗順応の低下
3　持久力の向上
4　臓器の萎縮

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	運動耐久力は低下する。
2	正答	瞳孔径の縮小と網膜機能の変化で、暗い場所に慣れるのに時間がかかる。
3	誤答	持久力は低下する。
4	誤答	臓器の萎縮は老年期の変化。

公式正答：2　明暗順応の低下

109A46　細菌性髄膜炎の症状（羞明）

区分：一般／分類：関連領域／主題：髄膜刺激症状と羞明／出典：午前問題PDF 20ページ

細菌性髄膜炎bacterial meningitis の症状はどれか。

1　羞明
2　羽ばたき振戦
3　Raynaud〈レイノー〉現象
4　Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	髄膜刺激により光に過敏になり羞明が出る。部屋を暗くして刺激を減らす。
2	誤答	羽ばたき振戦は肝性脳症。
3	誤答	Raynaud現象は寒冷刺激での手指の蒼白化で、膠原病などでみられる。
4	誤答	Blumberg徴候は腹膜炎の反跳痛。

公式正答：1　羞明

ポイント：羞明は髄膜炎のほか、角膜炎、虹彩炎、白内障、片頭痛でもみられる。

109A76　眼球に入る光の量の調節

区分：一般／分類：直接眼科／主題：眼の構造・機能／出典：午前問題PDF 29ページ

眼球に入る光の量を調節するのはどれか。

1　角膜
2　虹彩
3　瞳孔
4　水晶体
5　毛様体

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	角膜は最も強い屈折力をもつ透明な組織で、光量は調節しない。
2	正答	虹彩の筋（瞳孔括約筋＝副交感、瞳孔散大筋＝交感）が瞳孔径を変えて光量を調節する。
3	誤答	瞳孔は虹彩の中央の穴で、大きさを変えるのは虹彩の筋。
4	誤答	水晶体はピント（調節）を担う。
5	誤答	毛様体は水晶体の厚みを変える調節と房水の産生を担う。

公式正答：2　虹彩

ポイント：「光量＝虹彩」「ピント＝水晶体・毛様体」「屈折の主役＝角膜」。

109A79　重症筋無力症

区分：一般／分類：弱い関連／主題：重症筋無力症と眼／出典：午前問題PDF 30ページ

重症筋無力症myasthenia gravis で正しいのはどれか。

1　男性に多い。
2　心肥大を生じる。
3　朝に症状が強くなる。
4　自己免疫疾患である。
5　70 歳以上に好発する。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	女性に多い（若年発症）。
2	誤答	心肥大は生じない。
3	誤答	症状は夕方に強くなる（易疲労性、日内変動）。
4	正答	抗アセチルコリン受容体抗体による自己免疫疾患。
5	誤答	20〜40歳代の女性と50歳以降の男性に好発し、70歳以上に限らない。

公式正答：4　自己免疫疾患である。

ポイント：眼筋型では眼瞼下垂と複視が主症状。眼科を初診することも多く、眼科でも重要な疾患。

109A81　交感神経の作用（散瞳）

区分：一般／分類：関連領域／主題：自律神経と瞳孔／出典：午前問題PDF 30ページ

交感神経の作用はどれか。2つ選べ。

1　散瞳
2　精神性発汗
3　腸蠕動の促進
4　排尿筋の収縮
5　グリコーゲン合成の促進

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	交感神経は瞳孔散大筋を収縮させ散瞳させる。
2	正答	精神性発汗（手掌・足底）は交感神経の作用。
3	誤答	腸蠕動は副交感神経が促進する。
4	誤答	排尿筋の収縮は副交感神経。
5	誤答	グリコーゲン合成はインスリン・副交感優位で進む。交感神経は分解を促す。

公式正答：1　散瞳、2　精神性発汗

109A94　糖尿病患者のアセスメント（視力低下・緑内障）

区分：状況設定／分類：関連領域／主題：糖尿病網膜症／出典：午前問題PDF 36ページ

> 【状況設定文】A さん（56歳、男性、会社員）は、デスクワークが多い仕事をしている。40歳時の会社の健康診断で2型糖尿病と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1年前から、足のしびれが出現するようになった。

A さんの現在の状況のアセスメントで適切なのはどれか。

1　緑内障glaucoma が疑われる。
2　運動療法が必要である。
3　糖尿病性神経障害が疑われる。
4　高蛋白質の食事摂取が必要である。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	糖尿病患者の視力低下はまず糖尿病網膜症（黄斑浮腫、硝子体出血）を疑う。緑内障が疑われる根拠は乏しい。
2	誤答	腎症が進行した状態で運動療法の積極的な導入は適さず、状況のアセスメントとしても不適切。
3	正答	足のしびれは糖尿病性神経障害の典型的症状。
4	誤答	腎症では蛋白質は制限する。

公式正答：3　糖尿病性神経障害が疑われる。

ポイント：糖尿病網膜症は進行しても自覚症状が乏しく、視力低下を自覚したときには進行していることが多い。腎症の進行と網膜症の進行は並行しやすい。

109B08　老年期の身体的変化（水晶体）

区分：必修／分類：関連領域／主題：水晶体・加齢（老視）／出典：午後問題PDF 8ページ

老年期にみられる身体的な変化はどれか。

1　血管抵抗の増大
2　消化管の運動の亢進
3　水晶体の弾性の増大
4　メラトニン分泌量の増加

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	動脈硬化で血管抵抗が増大し収縮期血圧が上がる。
2	誤答	消化管運動は低下する。
3	誤答	水晶体の弾性は低下する。増大ではない。
4	誤答	メラトニン分泌は減少し、睡眠が浅くなる。

公式正答：1　血管抵抗の増大

109B12　三叉神経の機能（視覚・眼球運動の選択肢）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：脳神経と眼（対光反射・眼球運動）／出典：午後問題PDF 9ページ

三叉神経の機能はどれか。

1　視覚
2　眼球の運動
3　顔面の知覚
4　表情筋の運動

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	視覚は視神経（第 II 脳神経）。
2	誤答	眼球運動は動眼・滑車・外転神経。
3	正答	三叉神経は顔面の知覚神経で、角膜反射の求心路でもある。
4	誤答	表情筋の運動は顔面神経。

公式正答：3　顔面の知覚

ポイント：三叉神経第1枝（眼神経）は角膜・上眼瞼の知覚を担い、障害で角膜反射が低下し角膜障害が起こりやすくなる。

109B51　網膜剝離・硝子体手術後の体位

区分：一般／分類：直接眼科／主題：網膜剝離／出典：午後問題PDF 19ページ

A さん（59歳、女性）は裂孔原性網膜剝離と診断され、硝子体手術の際に硝子体腔中にガス注入を受けた。手術直後、病室での体位で適切なのはどれか。

1　坐位
2　腹臥位
3　仰臥位
4　側臥位

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	坐位ではガスが上方（前方）へ移動し、後方の網膜を押さえられない。
2	正答	ガスは上に浮くため、うつむくことで眼の後方の網膜（黄斑部など）にガスが当たり網膜を復位位置に保つ。
3	誤答	仰臥位ではガスが水晶体側に当たり、白内障や眼圧上昇の原因になる。
4	誤答	側臥位は裂孔の位置によっては指示されるが、「手術直後の基本」としては腹臥位。

公式正答：2　腹臥位

ポイント：体位は裂孔の位置により医師が指示する。ガスが吸収されるまで（数日〜数週）は航空機搭乗や高地への移動を避ける（気圧低下でガスが膨張し眼圧が上昇する）。

整理：うつむき姿勢は頸部・腰部の苦痛が強いため、専用の枕や休憩の工夫、精神的支援が看護の要点。

109B52　散瞳薬を用いる眼底検査の看護

区分：一般／分類：直接眼科／主題：検査・散瞳／出典：午後問題PDF 19ページ

散瞳薬を用いて眼底検査を受ける成人患者への対応で適切なのはどれか。

1　検査中は室内を明るくする。
2　散瞳薬の点眼は検査直前に行う。
3　検査前に緑内障glaucoma の有無を確認する。
4　検査後1時間で自動車の運転が可能になると説明する。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	散瞳を保ち眼底を見やすくするため室内は暗くする。
2	誤答	散瞳薬は効果発現に20～30分かかるため、検査直前ではなく前もって点眼する。
3	正答	散瞳により隅角が閉塞して急性緑内障発作を起こす危険があるため、閉塞隅角緑内障の有無を確認する。
4	誤答	散瞳と調節麻痺は4～5時間以上続くため、1時間で運転できるとは説明しない。

公式正答：3　検査前に緑内障glaucoma の有無を確認する。

ポイント：第114回午後52と同じ主題で繰り返し出題されている。

109B75　視覚障害者への避難所での対応

区分：一般／分類：直接眼科／主題：視覚障害者の看護／出典：午後問題PDF 27ページ

A さん（55歳、女性）は、1人暮らし。A さんには視覚障害があり、光と輪郭がぼんやりわかる程度である。食事の準備や室内の移動は自立している。震度6の地震が発生した。A さんは、避難所に指定されたバリアフリーの公民館に近所のB さんと避難した。公民館には複数の部屋がある。避難所の開設初日に医療救護班として看護師が派遣された。避難所生活を開始するA さんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1　B さんをA さんの介助者とする。
2　A さんの肩に触れてから声をかける。
3　A さんにはトイレに近い部屋を割りあてる。
4　移動するときはA さんの手を引っ張って誘導する。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	近所の人を介助者に指定するのは本人の意思と相手の負担を無視している。
2	誤答	先に声をかけて自分が誰かを伝えてから、必要に応じて触れる。いきなり触れると驚かせる。
3	正答	トイレに近い部屋は移動距離と危険を減らし、自立した生活を支える。
4	誤答	手を引っ張らず、介助者の肘や肩を持ってもらい半歩前を歩く。

公式正答：3　A さんにはトイレに近い部屋を割りあてる。

ポイント：光覚弁程度の視覚障害でも慣れた環境では自立できる。避難所では環境が変わるため、部屋の配置や動線を口頭で具体的に説明し、物の位置を変えない。

109B83　加齢黄斑変性の症状

区分：一般／分類：直接眼科／主題：加齢黄斑変性／出典：午後問題PDF 30ページ

加齢黄斑変性の症状はage-related macular degeneration どれか。

1　羞明
2　霧視
3　飛蚊症
4　眼圧の亢進
5　中心視野の欠損

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	羞明は白内障や虹彩炎で目立つ。
2	誤答	霧視は白内障などで起こる。
3	誤答	飛蚊症は硝子体の混濁や網膜裂孔・剝離の前兆。
4	誤答	眼圧の亢進は緑内障。
5	正答	黄斑部の障害で見ようとする中心が見えなくなる。周辺視野は保たれる。

公式正答：5　中心視野の欠損

ポイント：Amsler（アムスラー）チャートで格子のゆがみを自己チェックする。滲出型には抗VEGF薬の硝子体注射が行われる。禁煙が予防に重要。

109B92　甲状腺全摘後の症状（目が閉じにくい）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：顔面神経と眼／出典：午後問題PDF 34ページ

> 【状況設定文】A さん（35歳、女性）は、昨年結婚し、夫（50歳）と2人暮らし。最近2か月で5kgの体重減少、首の違和感と息苦しさ、心悸亢進、不眠のため内科を受診した。触診で甲状腺の腫脹、超音波検査で甲状腺内に数か所の石灰化が認められたため、甲状腺腫瘍の疑いで大学病院に紹介された。嗜好品：飲酒はビール700ml/日を週5日。趣味：ジョギングとヨガ。

検査の結果、A さんは甲状腺乳頭癌であり、甲状papillary adenocarcinoma of the thyroid 腺全摘出術を受けることになった。A さんは、手術前オリエンテーションの際「手術後にどんな症状が起こりやすいのか教えてください」と話した。この時のA さんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

1 「手がつる感じがあります」
2 「目が閉じにくくなります」
3 「声が出なくなります」
4 「唾液が多くなります」

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	副甲状腺が摘出・損傷されると低カルシウム血症でテタニー（手指のしびれ、手がつる）が起こる。
2	誤答	閉眼困難は顔面神経麻痺の症状。甲状腺手術の合併症ではない。
3	誤答	反回神経麻痺では嗄声になるが、声が全く出なくなるとは限らない（両側麻痺では呼吸困難）。
4	誤答	唾液分泌は変わらない。

公式正答：1 「手がつる感じがあります」

109B94　閉塞性黄疸（眼球結膜の黄染）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：黄疸と眼球結膜／出典：午後問題PDF 36ページ

> 【状況設定文】A さん（56歳、女性、会社員）は、夕食の1時間後から腹痛・嘔吐が出現し救急外来を受診した。2か月前から自然に消失する右季肋部痛を繰り返していた。身体所見：身長155cm、体重82kg。体温38.2℃、呼吸数16/分、脈拍110/分、血圧126/70mmHg。眼球結膜に黄染あり。右季肋部に圧痛あり。意識清明。検査所見：白血球14,960/μL、Hb 12.8g/dL。総ビリルビン8.7mg/dL、直接ビリルビン7.2mg/dL、アミラーゼ121IU/L、リパーゼ45IU/L、尿素窒素18.9mg/dL、血清クレアチニン0.98mg/dL。CRP 9.2mg/dL。腹部超音波検査所見：胆嚢壁の肥厚、胆嚢の腫大、総胆管の拡張、総胆管結石を認めた。

A さんの病態で正しいのはどれか。

1　急性胃炎
2　急性腎不全
3　閉塞性黄疸
4　溶血性貧血

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	急性胃炎では黄疸はない。
2	誤答	腎機能は正常。
3	正答	総胆管結石による胆汁うっ滞で直接ビリルビンが上昇し、眼球結膜から黄染が現れる。
4	誤答	溶血性貧血では間接ビリルビンが上昇し、Hbは低下する。

公式正答：3　閉塞性黄疸

ポイント：黄疸は眼球結膜（強膜）に最初に現れる。皮膚より先に気付ける部位として観察する。

109B115　糖尿病網膜症による視力障害とインスリン自己注射

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：糖尿病網膜症／出典：午後問題PDF 50ページ

> 【状況設定文】A さん（75歳、男性）は、妻（70歳）と2人暮らし。2型糖尿病の治療中で、2年前から1日2回朝・夕食前に混合型インスリン注射が開始となった。その後、糖尿病性網膜症による視力障害が進んだため、現在は妻と一緒に単位数や針の確認をし、インスリンの自己注射を実施している。

外来受診時にA さんの妻から外来看護師に「2人で協力してインスリン注射することには慣れてきました。たまには夜に夫とゆっくり和食を食べに行きたいのですが、外出時の注射で気を付けることを教えてほしい」と相談があった。A さんと妻への外来看護師の指導内容で適切なのはどれか。

1 「お店に着いたらすぐに注射を打ちましょう」
2 「インスリンを常温で持ち運ぶことはできません」
3 「注射ができる場所をお店の人に確認しましょう」
4 「普段よりもインスリン量を増やす必要があります」

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	混合型インスリンは食事の直前に注射する。店に着いてすぐでは食事まで時間が空き低血糖の危険がある。
2	誤答	使用中のインスリンは常温（室温）で持ち運べる。
3	正答	視力障害があり妻と確認しながら注射する必要があるため、落ち着いて注射できる場所を事前に確認する。
4	誤答	外食だからといって自己判断で量を増やさない。

公式正答：3 「注射ができる場所をお店の人に確認しましょう」

ポイント：視力障害のある患者の自己注射支援：音や目盛りの大きい注入器、単位数の読み上げ、家族との二重確認、低血糖時の対応の共有。